

# 크레아틴 복용 가이드

Creatine Monohydrate — 근육운동을 하는 건강한 성인에서 가장 근거가 많은 스포츠 보충제입니다. 효과는 “운동을 대신하는 것”이 아니라, 짧고 강한 운동을 반복할 때 ATP 재생을 보조하는 쪽에 가깝습니다.

## 핵심 숫자만 먼저 보기

기본 유지량

**3~5g**

하루 1회, 매일

로딩 선택 시

**20g**

5g씩 4회, 5~7일

효과가 큰 운동

**≤30초**

반복 고강도 운동

초기 체중 증가

**수분**

근육 내 저장 증가

## 기대할 수 있는 효과와 한계



### 효과가 큰 경우

**반복 스프린트·웨이트·점프**처럼 짧고 강한 운동에서 수행능력 보조 효과가 가장 뚜렷합니다.

**저항운동과 병행**할 때 근육 및 체지방량 증가가 더 잘 관찰됩니다.

**채식 위주 식사**처럼 식이 크레아틴이 낮은 사람은 저장량 증가 폭이 클 수 있습니다.

**운동 없이 복용**하면 근육 증가보다 수분 증가가 먼저 보일 수 있고, 인지 기능 목적 복용은 아직 연구 단계입니다.

## 복용법: 단순하게 가는 것이 가장 안전합니다

| 방법       | 용량 언제 쓰나                                     | 메모           |
|----------|----------------------------------------------|--------------|
| 유지량부터 시작 | <b>3~5g/일</b> 대부분의 일반 성인에게 권장                | <b>1순위</b>   |
| 로딩 후 유지  | <b>20g/일 → 3~5g</b> 빠른 포화가 필요할 때만 선택         | <b>속불편 ↑</b> |
| 타이밍      | <b>식후·운동 후</b> 탄수화물 포함 식사와 함께 가능             | <b>꾸준함</b>   |
| 제품 형태    | <b>Monohydrate</b> HCl·Kre·Alkalyne보다 근거가 많음 | <b>표준</b>    |

### TAKE HOME

크레아틴은 “매일 3~5g + 저항운동 + 충분한 단백질/수분” 조합에서 가장 현실적인 이득을 냅니다. 고용량 로딩은 필수가 아니며, 설사·복부팽만이 있으면 2~3g씩 나눠 먹거나 유지량부터 시작하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ISSN 2017 position stand · AIS Creatine Fact Sheet · Mayo Clinic 2026 · Nutrients 2025. 본 자료는 일반 교육용이며 개인 처방을 대체하지 않습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/lifestyle/creatine-guide/](http://gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/lifestyle/creatine-guide/)

## 부작용·검사 해석·복용 전 상담 대상

건강한 성인이 권장량으로 복용할 때는 대체로 안전한 편이지만, 신장 질환·신장 기능 저하 위험 요인·신독성 약물 복용이 있으면 이야기가 달라집니다.

### 자주 묻는 부작용: 대부분은 조절 가능합니다



#### 흔한 변화와 오해

- 체중 증가** 초기에는 근육 내 수분 저장 증가로 0.5~1kg 안팎이 늘 수 있습니다. 지방이 늘었다는 뜻은 아닙니다.
- 속불편·설사** 로딩기나 한 번에 많이 먹을 때 흔합니다. 유지량부터 시작하거나 나눠 복용하세요.
- 크레아티닌** 혈액검사 creatinine은 올라 보일 수 있어 eGFR이 낮게 계산될 수 있습니다. 검사 전 복용 사실을 알려주세요.
- 탈모** 2025년 12주 RCT에서는 DHT·테스토스테론·모발 지표 차이가 확인되지 않았습니다.

### 복용 전 의사와 먼저 상의해야 하는 경우

- 만성 신장질환 또는 **eGFR <60** — 권장량이라도 복용 전 상담이 필요합니다. eGFR <30, 투석 중인 경우는 임의 복용을 피하세요.
- 당뇨·고혈압·단일 신장 — 신장 기능 저하 위험이 있으면 시작 전 creatinine/eGFR 확인이 좋습니다.
- NSAIDs**를 자주 복용하거나 신장에 부담이 될 수 있는 약(일부 이뇨제·항생제·면역억제제 등)을 쓰는 경우 병용을 점검하세요.
- 임신·수유·청소년은 일반 건강기능식품처럼 단순 적용하기 어렵습니다. 제품 라벨보다 진료 상담을 우선하세요.
- 여러 보충제를 동시에 복용하면 카페인·이노 성분·간·신장 부담 성분이 겹칠 수 있습니다. 성분표를 함께 확인하세요.

### 진료실에서 이렇게 확인하면 안전합니다

#### 중단하고 상담할 신호

소변량 감소, 붓기, 호흡곤란이 생기는 경우  
심한 설사·복통이 반복되어 탈수가 걱정되는 경우  
검사에서 **creatinine** 급상승 또는 eGFR 급감이 나온 경우  
고용량·로딩 후 이상 증상이 생긴 경우

#### 검사 해석 팁

검사 전 **복용 사실**과 하루 용량을 의료진에게 알려주세요.  
**creatinine** 기반 eGFR은 보충제 영향으로 낮게 보일 수 있습니다.  
필요 시 의료진 판단으로 **cystatin C**, 소변검사, 재검 시점 조정 등을 고려합니다.  
목표는 “검사 수치를 숨기는 것”이 아니라 **실제 신장 기능을 정확히 보는 것**입니다.

#### ONE LINE SUMMARY

건강한 성인이라면 크레아틴 모노하이드레이트 3~5g/일이 표준입니다. 신장질환, 신장 위험 요인, 신독성 약물, 임신·수유·청소년은 “시작 전 상담”이 안전선입니다.

#### 광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

주요 참고: ISSN 2017 · AIS 2024 · Mayo Clinic 2026 · JISSN 2025 hair-loss RCT · Frontiers in Nutrition 2024 cognition review.

제품 선택 시 단일 성분 크레아틴 모노하이드레이트, 정확한 g 단위 표기, 불필요한 복합 성분이 적은 제품을 우선 확인하세요.

UPDATED 2026-05